Disciplina: PEDIATRIA II

Dermatoses

Prof. PATRICIA DAHAN



SUPREMA

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

PLANO DE ENSINO

Curso: Medicina

Data: 2º Semestre de 2023 **Período:** 8º

Professor: PATRICIA DAHAN

Conteúdo Programático Abordado nesta aula:
Dermatoses

SUPREMA



Objetivos da aula

- ✓Descrever as lesões observadas
- ✓Diagnosticar as principais dermatoses congênitas e adquiridas da infância
- ✓Orientar tratamento (sem as doses) e cuidados específicos

SUPREMA

Exame da pele

- Exige boa iluminação (melhor luz natural)

- Avaliar morfologia das lesões , distribuição, início e evolução , sintomas associados (prurido, dor ...), circunstâncias em que apareceram e alterações de estado geral do paciente

SUPREMA

Lesão na pele

- Muitas vezes está relacionada a uma enfermidade sistêmica





SUPREMA

Definições

- Erupção : aparecimento mais ou menos rápido de inúmeras lesões
  - Monomorfa ou polimorfa
  - Centrípeta ou centrífuga
- Descrever progressão da lesão
  - Serpiginosa (sinuosa) por exemplo
  - Vesículas; úlceras ; crostas (varicela)
- Momento do aparecimento da lesão
  - Congênito ou adquirido
  - Pós trauma ou exposição solar

SUPREMA

Outros elementos de valor

- Semiologia subjetiva
  - sensibilidade
  - prurido

- Sinais e sintomas extra cutâneos:
  - febre,
  - linfonados aumentados, hepatoesplenomegalia
  - emagrecimento, prostração , palidez...

SUPREMA

Semiologia armada

- Biopsia (neoplasias , tuberculose etc...)
- Luz de Wood (micoses principalmente)
- Microscopia de epiluminescência (dermatoscópio portátil , aumento em até 10x)
- Curetagem metódica
- Digitopressão (estrófulo ou petéquia?)
- Provas farmacológicas (histamina ou pilocarpina)

SUPREMA

DISCROMIAS

- ALBINISMO : ausência total do pigmento melânico , hereditária



- VITILIGO : manchas acrômicas , geralmente simétricas , tendência familial



SUPREMA

DISCROMIAS

- PITIRÍASE ALBA (ou eczemátides) :

  manchas hipocrômicas

  tamanho variado

  geralmente em face, membros superiores e tronco

  Etiologia indeterminada

  Associação frequente com atopia







SUPREMA

Tratamento Pitiríase alba

- **Controle ambiental (evitar temperatura elevada do banho e uso excessivo de sabões)**
- **Hidratação/ emolientes (creme de uréia 5% -10%)**

Nos quadros prolongados: Corticoides tópicos de baixa potência

SUPREMA

DISCROMIAS

- MANCHA MONGÓLICA :

manchas hipercrômicas azuladas geralmente em região sacra e que costumam involuir.



SUPREMA

DISCROMIAS

- FOTODERMATITE : manchas geralmente inicialmente eritematosas , as vezes bolhosas que se tornam hipercrômicas. Causadas pelo contato com furocumarinas e exposição ao sol





- HIPERCROMIA POR DROGAS :Localizadas ou generalizadas (anticonvulsivantes, antimaláricos, hormônios etc)

SUPREMA

DISCROMIAS

- NEVO CONGÊNITO : lesões benignas de cor castanho- preta constituída por melanócitos. Pode se transformar em melanomas em até 12% dos casos quando grandes





- MELANOMA : neoplasias malignas



SUPREMA

ALGUMAS DERMATOSES PREDOMINANTEMENTE ERITEMATOSAS

URTICÁRIA: Placas e pápulas eritemato-edematosas, de tamanhos e formas variáveis , pruriginosas e de duração efêmera. Desaparecem à digito pressão.

15 a 20% da população tem

pelo menos um episódio/vida.

Aguda ou crônica (> 6 semanas)

Etiologias: drogas, alimentos,

inalantes, parasitoses, infecções,

doenças sistêmicas, agentes físicos, agentes psicogênicos.



SUPREMA

TRATAMENTO URTICÁRIA

- **Identificar e eliminar agente causal (alimentos, corantes, medicamentos, etc)**
- **Anti-histamínicos via oral :**
  Loratadina, Cetirizina ,Fexofenadina, Desloratadina, Hidroxizina
- **Corticóide via oral casos mais graves**
- **Nas emergências (edema de laringe ou broncoespasmo): Adrenalina (1mg/ml) 0.01 mg/kg – via subcutânea (até 3x)**

SUPREMA

DERMATOSES PREDOMINANTEMENTE ERITEMATOSAS

- ERITEMA TÓXICO NEONATAL : máculas eritematosas , pápulas ou até mesmo pústulas mais em parte anterior de tórax , face e extremidades nos primeiros dias de vida . Autolimitado e benigno



SUPREMA

DERMATOSES ERITEMATOESCAMOSAS

- PSORÍASE : lesões de tamanho variado eritematoescamosas (escamas prateadas) mais em faces extensoras / várias formas clínicas



DERMATOSES ERITEMATOESCAMOSAS

- DERMATITE SEBORREÍCA INFANTIL : Lesões eritemato descamativas papulosas, não pruriginosas / etiologia desconhecida em face, couro cabeludo, axilas, ou região de fraldas nos primeiros meses de vida







SUPREMA

Tratamento Dermatite seborréica

- **Óleo mineral ou óleo de amêndoas (remover crostas) – 1x dia.**
- **Ácido salicílico 5% em pomada (sobrancelhas ou retroauricular)**
- **Shampoo sulfeto de selênio (crianças maiores).**
- **Corticoídes tópicos de baixa potência – 3 a 5 dias (Desonida creme 0.05%, Hidrocortisona 1%).**

SUPREMA

DERMATOSES ERITEMATOVESICULARES

DERMATITE ATÓPICA (ou ECZEMA ATÓPICO) :

- doença inflamatória crônica mais freqüente (20% das crianças) ,
- Lactentes : face, couro cabeludo , tronco e região extensora dos membros
- Pré escolares e escolares: mais em **regiões flexoras dos membros** (antecubital e poplítea) , também punhos, tornozelos, região perioral e pescoço)





SUPREMA

DERMATOSES ERITEMATOVESICULARES

DERMATITE ATÓPICA (ou ECZEMA ATÓPICO) :



- **intenso prurido** que freqüentemente leva a liquenificação.
- Complicações infecciosas (S.Aureus)
- Impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes.

(sono, auto estima , fatiga , ansiedade, depressão...)

- 70% resolvem até adolescência

SUPREMA

Tratamento Dermatite atópica

1) **EVITAR OU CONTROLAR FATORES DESENCADEANTES**
   - **Extremos de temperature**
   - **Banhos quentes e demorados**
   - **Hidratantes, detergentes alcalinos e outros produtos de higiene inadequados**
   - **Roupas sintéticas**
   - **Cloro de piscina**
   - **Exposição a alimentos (trigo, leite, ovo e soja)**
   - **Aeroalérgenos**
   - **Inalantes**
   - **Estresse emocional**
   - **Controlar infecções de pele**

Tratamento Dermatite atópica

2) RESTAURAR A BARREIRA CUTÂNEA : ponto chave para controle da doença.
O uso de hidratantes reduz xerose, prurido e diminui processo inflamatório

- produtos de higiene adequados (sabonete liquido, pH ácido ou “Syndet”)
- banho curto , água morna.
- hidratantes adequados (ureia, glicerol, ceramidas, óleo de canola ou girassol)
- “Wet wraps”: podem ser associadas aos hidratantes (15 a 20 min após o banho, passer hidratante, vestir roupa de algodão justa úmida e roupa seca por cima, deixar algumas horas ou a noite)

Tratamento Dermatite atópica

3) TERAPIA TÓPICA

- Corticoides
  - uma vez ao dia em lesões em atividade
  - não ocluir/ creme ou loção em lesões agudas e pomada nas lesões crônicas
  - Baixa potência : hidrocortisona, dexametasona (face e dermatite leve)
  - Média potência : mometasona desonida (tronco e dermatite moderada)
- Inibidores tópicos da Calcineurina (Para maiores de 2 anos : Pimecrolimus (dermatite leve) e Tacrolimus (Dermatite moderada e grave)

4) **TRATAMENTO SISTÊMICO :** para casos graves resistentes aos outros tratamentos (corticoide oral , ciclosporina , methotrexate , terapia anticorpo monoclonal)

Tratamento Dermatite atópica

5) FOTOTERAPIA UV : dificuldade de acesso aos centros de fototerapia, 2 a 3x semana por meses e risco acumulativo

6) ANTI HISTAMÍNICOS : controle principal do prurido é com a restauração da barreira cutânea – indicar cetirizine ou loratadina quando há doença concomitante como rinoconjuntivite.

7) **REDUÇÃO DA COLONIZAÇÃO E INFECÇÃO** : antibioticoterapia oral ou tópica e para diminuir a colonização : banhos com hipoclorito de sodio+ embrocação nasal com mupirocina

SUPREMA

DERMATOSES ERITEMATOVESICULARES

- ECZEMA DE CONTATO : lesões eritematovesiculares com posterior descamação em área que tiveram contato com determinadas substâncias irritantes (níquel , mércurio etc..). Muito prurido





DERMATOSES ERITEMATOVESICULARES

- DERMATITE DAS FRALDAS : provavelmente a dermatite mais comum da infância , dermatite de contato que evoluiu com irritação e maceração da pele

fatores associados: fraldas,

fezes/urina, fricção,

Temperatura, irritantes químicos,

micro-organismos.



SUPREMA

Cuidados e tratamento
Dermatite das fraldas

Prevenção e cuidados:

- **Freqüência de troca de fraldas**
- **Capacidade de absorção das fraldas**
- **Higiene diária com água morna frequente**

Tratamento:

- **Cremes de barreira: óxido de zinco ou dexpantenol.**
- **Corticóide tópico de baixa potência (Hidrocortisona – 2 a 3 dias) em caso de hiperemia intensa.**
- **Nistatina ou Miconazol 1% (14 dias) se infecção fúngica.**

SUPREMA

DERMATOSES ERITEMATOVESICULARES

MILIÁRIA:

Lesões vesiculares, conteúdo claro ou pápulas , em grande extensão corporal ;
Comum em neonatos e lactentes

Calor excessivo,
umidade, febre



SUPREMA

Tratamento miliária

Tratamento:

- **Resfriamento da pele**
- **Banhos de amido de milho**
- **Evitar sol, calor, roupas em excesso**
- **Pasta d'água ou calamina 1-2%**

SUPREMA

ASPECTOS SEMIOLÓGICOS DE VALOR DIAGNÓSTICO

- **PIODERMITES : INFECÇÕES CUTÂNEAS CAUSADAS PELO ESTREPTOCOCO BETA HEMOLÍTICO A OU ESTAFILOCO AUREUS**



Impetigo : tipo de piodermite
mais freqüente em crianças
As lesões se assemelham a
“queimadura de ponta de cigarro”
com crosta melicérica , as vezes a apresentação pode ser vesícula ou bolha

SUPREMA

IMPETIGO







Pode vir acompanhado de febre e/ou adenomegalia regional

Tratamento Impetigo

- **Higiene das lesões com água e sabão, permanganato de potássio**
- **Antibioticoterapia tópica : mupirocina ou acido fusídico ou neomicina + bacitracina.**
- **Antibioticoterapia oral: casos extensos, febre, associação com faringite e com proximidade cavidade oral – cefalexina, cefaclor, amoxicilina + clavulanato 7 a 10 dias**

SUPREMA

ASPECTOS SEMIOLÓGICOS DE VALOR DIAGNÓSTICO

- ERISIPELA : aumento de volume , rubor e calor bem delimitados em membros inferiores , superiores ou face
- CELULITE : mais profunda que a erisipela , acometendo subcutâneo , sem bordos definidos



Erisipela

Celulite





SUPREMA

DERMATOZOONOSES

ESCABIOSE HUMANA (Sarcoptes scabiei)

intenso prurido noturno; história de contactantes com lesões semelhantes

Lesões vesico- papulares, eritematosas: túnel acastanhado sinuoso com pápula

Período de incubação:

4 a 6 semanas no 1°contato.

Inicio insidioso.



Locais : interdigital, punhos, axilas,

Abdome , genitália etc....

SUPREMA

ESCABIOSE





SUPREMA

Tratamento escabiose

- **Identificar e tratar contatos.**
- **Lavar e expor diariamente roupas pessoais e de cama (agua quente ou passar ferro) – opção : saco fechado por 7 dias**
- **Permetrina 5% (1ª opção): aplicar corpo e couro cabeludo (apenas em lactentes incluir face- aplicar por 8 a 14 horas. Lavar de manhã e repetir em 7-14 dias - Contra indicado em <2 meses**
- **lactentes < 2 meses e gestantes : Pasta d'água com enxofre 5 a 10% por 3 noites consecutivas- lavar de manhã- repetir após 7 dias.**
- **Via oral: Ivermectina (para maiores de 15kg): 0,2mcg/kg/dia – Repetir a dose após 1 semana**
- **Benzoato de benzila 25% (diluir 1:3 ou 1:4):Usar 3 noites consecutivas. Repetir após 7 dias. Aplicar à noite e tirar pela manhã, com banho.**

SUPREMA

DERMATOZOONOSES

PEDICULOSE (Pediculus humanus capitis , P.humanus corporis, P.Phthirus pubis) muito pruriginosa, Pode haver infecção secundária e adenopatia satélite.





SUPREMA

Tratamento Pediculose

- **Identificar e tratar contatos.**
- **Lavar e expor diariamente roupas de cama.**
- **Não prender cabelos úmidos.**
- **Retirar lêndeas (pente fino/ solução a 50% de vinagre em água morna).**
- **Permetrina xampu 1% aplicar por 10 a 15 minutos, passar pente fino e enxaguar aplicação única e repetir se necessário após 7 dias**
- **Monosulfiram 25% loção (1:3): deixar no couro cabeludo por 8 horas e repetir se necessário após 7 dias**
- **Deltametrina xampu por 5 min – 4 dias consecutivos e repetir em 7 dias**
- **Ivermectina (não aprovada pelo FDA como pediculicida mas algumas comprovações em estudos) – 200 a 400mcg/kg/peso. Repetir a dose após 1 semana. Contra indicado em menores de 15kg.**

SUPREMA

DERMATOZOONOSES

LARVA MIGRANS (“Bicho geográfico”)

trajeto sinuoso eritematopapuloso , intensamente pruriginosa / principalmente região plantar / Também glúteos, dorso, coxas/ Larva de nematódeos de cão e de gato penetram na pele exposta e essas larvas migram através da epiderme.





SUPREMA

Tratamento Larva Migrans

- **Desaparece espontaneamente em 4 a 6 semanas**
- **Leves: Tiabendazol pomada 2 vezes ao dia por 15 dias**
- **Maciça: Tiabendazol: 25 a 50 mg/kg/dia 2 vezes ao dia por 3 dias**
  OU Albendazol 400 mg – dose única diária por 1 a 3 dias
  OU Ivermectina - dose única.

SUPREMA

MICOSES SUPERFICIAIS

- DERMATOFITOSES : infecções por fungos dermatófitos que podem acometer o couro cabeludo e a pele. Entre elas : tinea capitis, tinea corporis, tinea cruris , tinea pedis etc...





SUPREMA

Tratamento Tinea

TINEA CAPITIS:

- **Itraconazol: 3-5 mg/kg/dia 2-4 sem**
- **Fluconazol: 6 mg/kg/dia (>12 anos) 20 dias**
- **Terbinafina: 2-6 mg/kg/dia 2 a 6 sem**
- **Griseofulvina: 10 a 20 mg/kg/dia (>2 anos) por 6 a 8 semanas**

+ associado ao Xampu de sulfeto de selênio2,5% 2x semana

TINEA CORPORIS

- **Imidazólicos tópicos por 4 semanas: Cetoconazol 2%, ou Clotrimazol 2% ou Tioconazol 1%**

SUPREMA

MICOSES SUPERFICIAIS

- CERATOFITOSES : principal é PITIRÍASE VERSICOLOR (Malassezia furfur)
  - máculas hipocrômicas , hipercrômicos ou levemente eritematosas com escama fina (furfurácea)
  - tronco, membros superiores , região cervical e face (mais comum em crianças
  - Áreas de implantação dos cabelos (concentração de glândulas sebáceas).
  - Fatores predisponentes: genética, condições favoráveis (substâncias emolientes, ambientes quentes/úmidos, sudorese excessiva, desnutrição, imunossupressão).

SUPREMA

Pitiríase versicolor





SUPREMA

Tratamento Pitiríase versicolor

- **Higiene**
- **Antifúngicos tópicos nas lesões de pele: Cetoconazol ou Micoconazol ou Cotrimazol 1 vezes ao dia por 30 dias**
- **Xampu de sulfeto de selênio 1 ou 2,5 % ou de cetoconazol 2% diariamente por uma a 2 semanas depois 1 a 2x semana por meses como prevenção até 2 meses pós cura clínica ou Cetoconazol.**
- **Sistêmico discutível : fluconazol ou itraconazol**

SUPREMA

MICOSES SUPERFICIAIS

- CANDIDÍASE : oral (“sapinho”) comum em recém nascidos ; candida albicans na dermatite das fraldas ou agente da queilite angular nas unhas





Tratamento Candidíase

ORAL

- **Nistatina em suspensão oral 100.000 UI/ml: aplicar 2 ml de 6/6 horas por 10 a 14 dias. (até 2 dias após sumirem as lesões)**
- **Miconazol gel 7 a 14 dias**
- **Esterelizar bicos e chupetas e verificar contaminação do seio materno**

REGIÃO DE FRALDAS

- **Nistatina creme 6/6 horas 7 a 14 dias**

SUPREMA

DERMATOVIROSES

- MOLUSCO CONTAGIOSO (Poxvírus) : lesões únicas ou múltiplas papulosas da cor da pele e com umbilicação central ; assintomática; curetagem : material esbranquiçado transmissão interpessoal , comum em freqüentadores de piscina pacientes com dermatite atópica são mais susceptíveis.



SUPREMA

Tratamento molusco contagioso

Pode - se optar por não tratar: autolimitado – desaparecimento em 6meses a 2 anos.

- **Expressão manual + tintura de iodo**
- **ou Substâncias químicas: podofilina 20% - hidróxido de potássio 5 a 10%**
- **ou Laserterapia/ crioterapia**

SUPREMA

DERMATOVIROSES

- VERRUGAS (Papilomavírus HPV pertencentes ao grupo dos papovavírus) : mais comum é verruga vulgar (pápula ceratósica com pontos negros na sua superfície) mais em mãos ; também verruga plantar , filiforme (face e região cervical)



SUPREMA

Tratamento verrugas

- **Ácido salicílico sobre a verruga, seguido de oclusão, em dias alternados.**
- **OU Eletrocoagulação e curretagem.**
- **OU Ácido nítrico fumegante.**

SUPREMA

DERMATOVIROSES

- HERPES SIMPLES (HSV 1e 2) : tipo 1 região orofacial e tipo 2 genital / no tipo 1 : a primoinfecção é a gengivoestomatite / no tipo 2 : a infecção genital primária em crianças é rara (abusos sexuais) mas pode ocorrer na transmissão vertical





SUPREMA

DERMATOVIROSES

- HERPES ZOSTER (Vírus varicela zoster) : vírus fica em latência após quadro de varicela ou infecção subclínica ; raro em crianças ; as lesões seguem trajeto de um nervo que geralmente é intercostal ou trigêmeo (mais grave)





Zoster

ADAM.

SUPREMA

Referências

- MARCONDES, E. et al. **Pediatria básica**. São Paulo: Sarvier; 2003.
- LOPES, F.A; DIOCLÉCIO,C.J; BURNS,D.A.R. **Tratado de Pediatria- Sociedade Brasileira de Pediatria.** São Paulo : Manole 3ª Ed. 2017.

- Documento Científico SBP Departamento Científico de Dermatologia (2016 - 2018) Infecções cutâneas parasitárias: aspectos clínicos e atualização terapêutica.
- PRONAP - SBP VOL 24 (1) – 2022 – Dermatite atópica : abordagem global atualizada

SUPREMA